



Educação do Paciente e Prontidão para Mudança: Estratégias Práticas



Educação do Paciente e Prontidão para Mudança: Estratégias Práticas

Conteúdo

- O que é o modelo transteórico de Prochaska e DiClemente?
- Por que entender o estágio de mudança do paciente é essencial para melhorar a adesão ao tratamento?

Objetivo

Apresentar técnicas práticas para **conduzir a educação do paciente** em diferentes estágios de prontidão para mudança, **promovendo maior adesão ao tratamento.**



Lembrete



O modelo biopsicossocial de atenção à saúde considera que **avaliar, intervir e vencer obstáculos psicossociais**, assim como modificar comportamentos, são tão importantes quanto qualquer intervenção de natureza física.



- Educação reduzindo crenças de ameaça.
- Letramento em saúde.
- Estímulo à pró-atividade.



- Redução do medo relacionado à dor e aumento da confiança na autoeficácia.



- Tratamento e adesão a hábitos de vida mais saudáveis.

Fonte: Çalişkan; Gokkaya, 2025.

Imagens produzidas com inteligência artificial.



Crença Disfuncional > Comportamento Atual



Crença Pensamento

Não consigo
levantar meu braço
porque meu tendão
está rompido.



Emoção Sentimento

Sinto medo de
me machucar
ao me movimentar.
O nível do meu medo
está em 80%.



Ação Comportamento

Respeito meu
medo evitando
mover meu braço.

Pensamento Alternativo > Novo Comportamento



Crença Pensamento

Meu médico explicou
que meu tendão não
está mais inflamado e
que foi feito para
resistir ao uso.



Emoção Sentimento

Sinto que tenho
controle sobre o
meu medo, e isso me
deixa mais confiante.
O meu medo
está em 50%.



Ação Comportamento

Movo meu braço
em elevação de
maneira gradativa,
desafiando meu
medo e retomando
a minha vida.



O Modelo Transteórico e seus Estágios

Os 5 estágios de mudança de comportamento



**Recaídas
vs.
Motivação**



O Modelo Transteórico e seus Estágios

ESTÁGIO	INTENÇÃO DE MUDANÇA DE COMPORTAMENTO
Pré-contemplação	É o estágio em que não há intenção de mudança de comportamento em um futuro próximo. As pessoas, nesse estágio, não estão cientes ou não enxergam seus problemas.
Contemplação	É o estágio em que as pessoas estão conscientes de que existe um problema e pensam em superá-lo, mas ainda não assumiram o compromisso de agir. Podem permanecer nesse estágio por longos períodos.
Preparação	Nesta fase, os indivíduos pretendem tomar medidas em um certo período de tempo, como em um mês. Realizam algumas alterações no comportamento, mas ainda não alcançaram uma ação efetiva. Pretendem agir em um futuro próximo.
Ação	É a fase em que os indivíduos modificaram seu comportamento nos últimos seis meses a fim de superar os problemas. Nesse estágio, as modificações tendem a ser mais visíveis e, por isso, recebem maior reconhecimento externo.
Manutenção	É o estágio em que as pessoas trabalham para prevenir a recaída e consolidar os ganhos durante a ação por períodos mais longos do que seis meses.



Entrevista Motivacional

É uma técnica de **conversação colaborativa**, que visa **fortalecer a motivação e o comprometimento individual com a mudança**. Auxilia o indivíduo a identificar as razões para modificar um comportamento específico, **estimulando-o a assumir um compromisso ativo** no processo de mudança.

Fonte: Rollnick; Miller; Butler, 2009.

É um método útil para aumentar a **aderência ao tratamento**, a satisfação e, ainda, alguns desfechos clínicos de pacientes com dor crônica, **especialmente quando é combinada com a educação em dor e uma abordagem multimodal de tratamento**.

Fonte: Nijs *et al.*, 2020
Chang *et al.*, 2015.



Quatro Princípios Práticos em Entrevista Motivacional

Fonte: Rollnick; Miller; Butler, 2009.



Expresse empatia
e evite confrontar
a ambivalência da
pessoa atendida.



Ajude a pessoa
a reconhecer as
discrepâncias entre o
comportamento atual
e seus **valores,**
objetivos e desejos.



Valorize o conhecimento
e as experiências prévias
da pessoa, destacando
atitudes que lhe trouxeram
resultados favoráveis
ou aprendizados.



Propicie a **autoeficácia,**
ou seja, a confiança da
pessoa em **resolver os**
próprios problemas
(minimetas).



O Modelo Transteórico e seus Estágios

Cada estágio requer uma abordagem educativa diferente



Pré-contemplação

Fornecer informação,
gerando dúvidas
construtivas.



Contemplação

Reforçar as
vantagens da
mudança.



Preparação

Planejar metas
realistas.



Ação

Acompanhar e
apoiar.



Manutenção

Reforçar conquistas
e prevenir recaídas.

Fonte: Prochaska; Velicer, 1997; Rollnick; Miller; Butler, 2009.

Imagens geradas com inteligência artificial.



Como educar pacientes na Pré-contemplação?



Como educar pacientes na Pré-contemplação?

Desafio

O paciente **não reconhece** que há um problema ou a necessidade de mudança.

Técnicas

Escuta ativa:

"Conte-me mais sobre a sua rotina e sua dor."

Perguntas abertas:

"Como a dor tem impactado a sua vida?"

Informações neutras:

"Muitas pessoas acham que certos sintomas são normais, mas podem indicar algo a ser tratado."

Fonte: Rollnick; Miller; Butler, 2009.



Estratégias para a Contemplação

Desafio

O paciente **reconhece o problema**, mas ainda **não está convencido a agir**.

Técnicas

Explorar prós e contras:

"Quais ganhos você acredita que teria se a dor melhorasse?"

Validação do medo e da insegurança:

"É compreensível estar em dúvida sobre o assunto, mas estamos aqui para ajudar."

Fonte: Rollnick; Miller; Butler, 2009.



Preparação e Ação: Como Incentivar a Mudança?

Desafio

O paciente está **disposto a mudar**, mas pode **não saber por onde começar**.

Técnicas

Estabelecimento de metas SMART (específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporais) personalizadas para promover autorregulação, comunicação centrada no paciente e potencializar resultados para tratamentos à dor crônica e à relacionada ao câncer.

Acompanhamento regular:

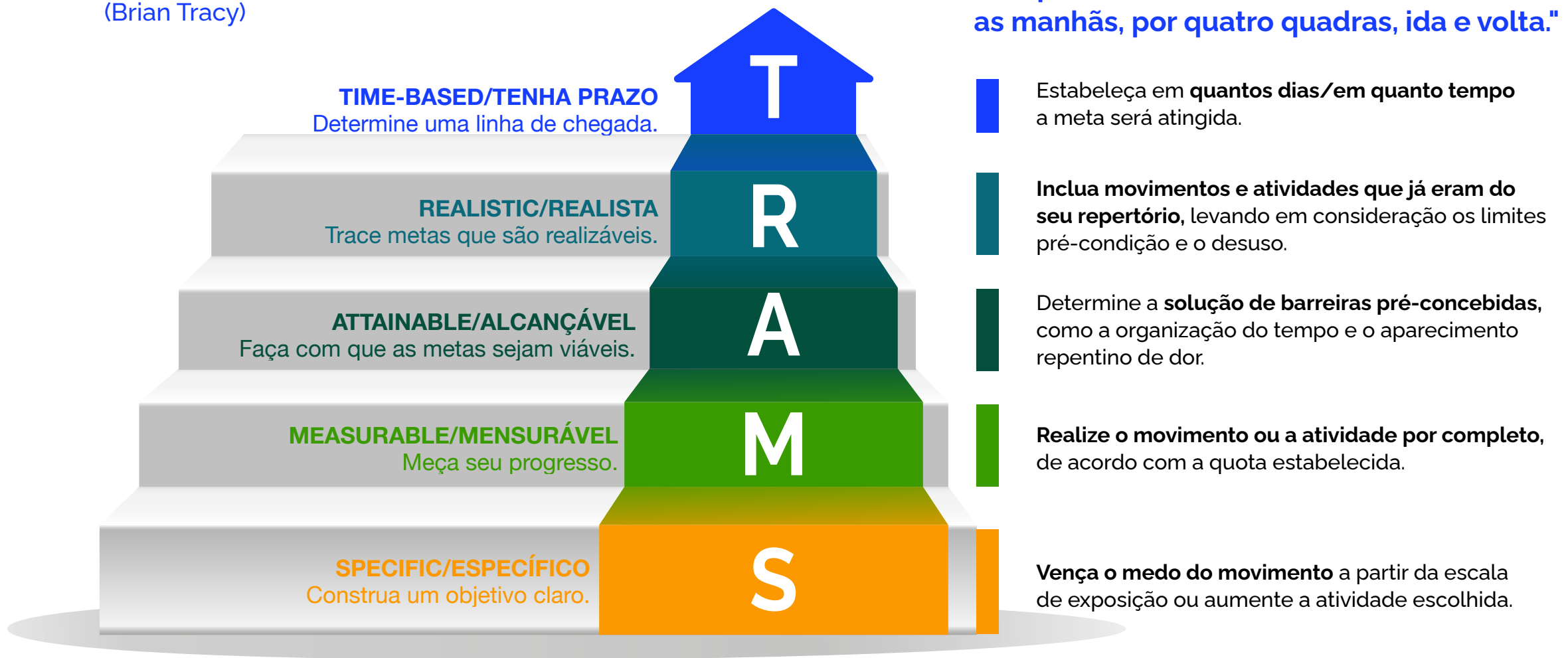
"Vamos iniciar com cautela e aos poucos, ajustando o manejo conforme necessário."

Fonte: Rollnick; Miller; Butler, 2009.



Estabelecendo metas SMART

"Metas permitem que você controle a direção da mudança em seu favor."
(Brian Tracy)





Material autoral de
Anamaria Siriani de Oliveira

Deixe aqui uma mensagem motivacional para os dias mais difíceis:

Está mais "natural", agora, exercitar-se diariamente?
() SIM () NÃO

Primeira conquista ★

Metade do caminho

Mudança de hábito ★

Exercícios como rotina ★

Crie, aqui, a sua legenda de cores para diferenciar exercícios ou atividades:



**Baixe e
imprima**
Utilize os
tamanhos
A3 ou A4.



Manutenção e como Prevenir Recaídas

Desafio

Sustentar mudanças a longo prazo.

Técnicas

Reforço positivo:

"Você já percorreu um longo e admirável caminho!"

Estratégias de enfrentamento para momentos difíceis:

"Até agora, o que mais ajudou você a manter o foco?"

Fonte: Rollnick; Miller; Butler, 2009.

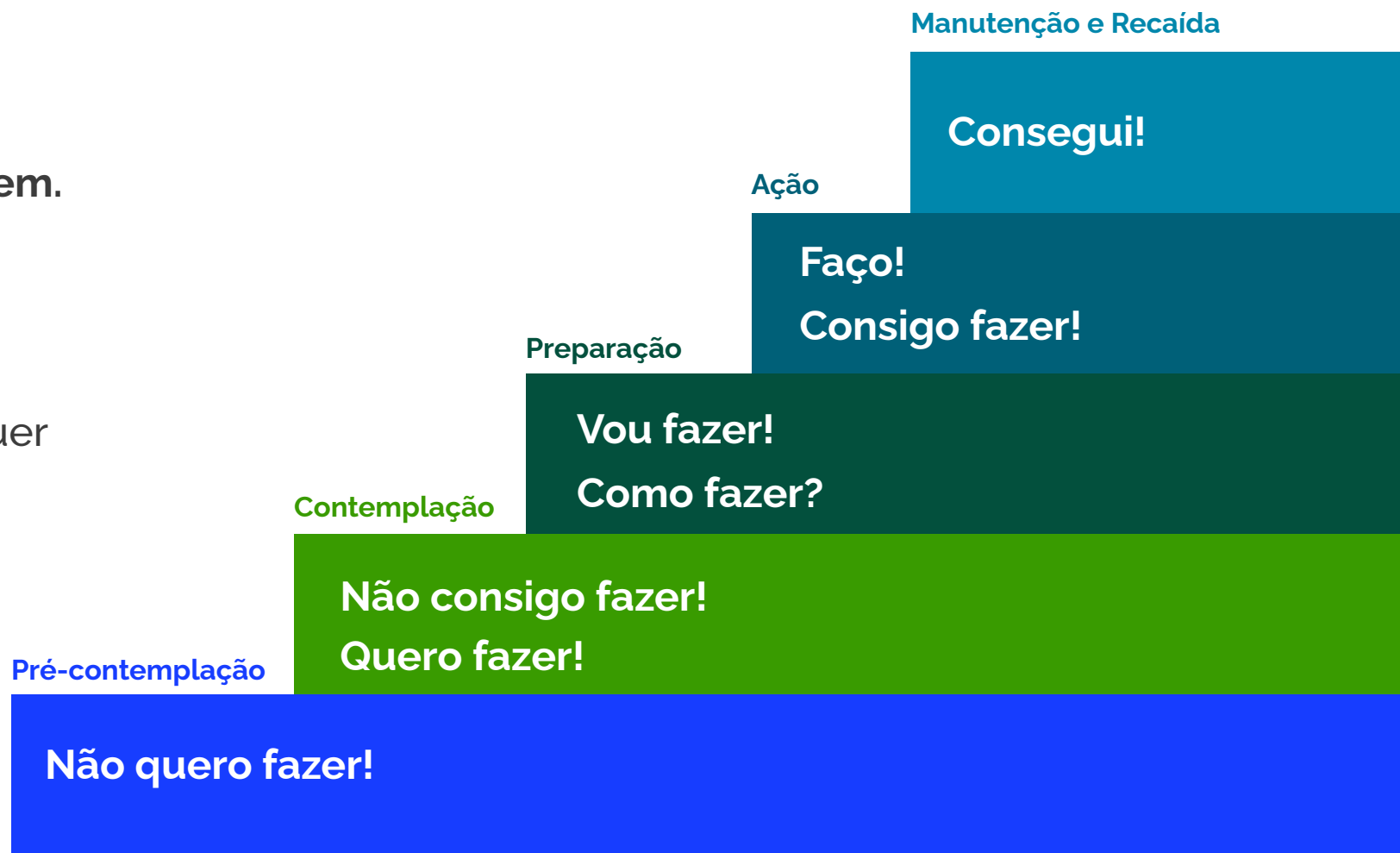


Conclusão

Para cada estágio, uma abordagem.

Usar elementos da Entrevista Motivacional é praticar o cuidado centrado no paciente. Assim, a personalização é um elemento chave de abordagem para qualquer condição crônica.

Educar e envolver o paciente é criar autonomia para que ele gerencie sua saúde de forma consciente e compromissada.





Para concluir

Ao utilizar uma **abordagem biopsicossocial**, considere avaliar, intervir e auxiliar o paciente a vencer barreiras. É essencial, ainda, reconhecer e apoiar-se em facilitadores que modificam comportamentos relativos ao sono, à alimentação, ao uso de substâncias, ao controle do estresse e ao sedentarismo, assim contribuindo com o tratamento da dor.



Referências bibliográficas

BAUER, S. M. *et al.* Veterans' pain management goals: changes during the course of a peer-led pain self-management program. **Patient Education and Counseling**, v. 99, n. 12, p. 2080–2086, dez. 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.pec.2016.07.034>. Acesso em: 30 ago. 2025.

BOVEND'EERDT, T. J.; BOTELL, R. E.; WADE, D. T. Writing SMART rehabilitation goals and achieving goal attainment scaling: a practical guide. **Clinical Rehabilitation**, v. 23, n. 4, p. 352–361, 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/0269215508101741>. Acesso em: 30 ago. 2025.

ÇALIŞKAN, E.; GÖKKAYA, F. Reviewing psychological practices to enhance the psychological resilience process for individuals with chronic pain: clinical implications and neurocognitive findings. **Current Pain and Headache Reports**, v. 29, n. 1, p. 68, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s11916-025-01373-4>. Acesso em: 30 ago. 2025.

EHRLICH, O. *et al.* Use of goals in cancer pain management: a systematic review. **Journal of Pain and Symptom Management**, v. 68, n. 3, p. e194–e205, set. 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2024.05.026>. Acesso em: 30 ago. 2025.

PROCHASKA, J. O.; VELICER, W. F. The transtheoretical model of health behavior change. **American Journal of Health Promotion: AJHP**, v. 12, n. 1, p. 38–48, 1997. Disponível em: <https://doi.org/10.4278/0890-1171-12.1.38>. Acesso em: 16 mar. 2025.



Ficha técnica

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Secretaria de Atenção Primária à Saúde - SAPS
Departamento de Prevenção e Promoção da Saúde - DEPPROS
Núcleo Técnico de Gestão da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS - NTG PNPIC.

Angela Fernandes Leal da Silva – Diretora do Departamento de Prevenção e Promoção da Saúde – DEPPROS.

Paulo Roberto Sousa Rocha – Coordenação Geral e Referência Técnica para a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS – NTG PNPIC/DEPPROS/SAPS/MS.

Daniel Miele Amado – Referência Técnica para a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS – NTG PNPIC/DEPPROS/SAPS/MS.

Nathalia Oliveira da Silva – Assessora Técnica no Núcleo Técnico de Gestão da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS – NTG PNPIC/DEPPROS/SAPS/MS.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

Reitoria
Ursula Rosa da Silva

Vice-Reitoria
Eraldo dos Santos Pinheiro

Coordenação Geral
Julieta Carriconde Fripp - Coordenadora da Cuidativa (Centro Regional de Referência em Cuidados Paliativos FAMED/UFPEL), Diretora da Faculdade de Medicina da UFPEL.

Coordenadora Adjunta
Simone da Fonseca Sanghi - Assistente Social da Cuidativa (Centro Regional de Referência em Cuidados Paliativos FAMED/UFPEL), Colaboradora dos processos de Gestão na Cuidativa.



UFPEL





Ficha técnica

CRÉDITOS DO CURSO

Coordenação Geral

Paulo Roberto Sousa Rocha
Julieta Carriconde Fripp
Simone da Fonseca Sanghi

Apoio Administrativo / Secretaria

Luciano Avila dos Santos

Coordenação de Conteúdo

Amirah Adnan Salman
Bárbara Cury Soubhia
Manuela Samir Maciel Salman

Consultoria e Revisão de Conteúdos

Amirah Adnan Salman
Andrea Cristina Lovato Ribeiro
Bárbara Cury Soubhia
Julieta Carriconde Fripp
Manuela Samir Maciel Salman
Nathalia Oliveira da Silva
Paulo Roberto Sousa Rocha
Simone da Fonseca Sanghi

Coordenação Pedagógica

Amirah Adnan Salman
Andrea Cristina Lovato Ribeiro
Bárbara Cury Soubhia
Manuela Samir Maciel Salman

Coordenação de Pesquisa e Relatórios

Luiz Augusto Facchini
Elaine Thumé
Elaine Tomasi

Coordenação de Mídias e Comunicação

Samir Salman
João Rocha Rodrigues
Luana Copini Jahn

Coordenação de Tecnologia e Informação

Alessander Osório

Coordenação da Produção

Alexandre Moretto Ribeiro
Andrea Cristina Lovato Ribeiro

Revisão Gramatical/Ortográfica e ABNT

Giulia M. Delazzeri

Produção Audiovisual

Eduardo Dias Abreu

Assistente de Produção Audiovisual

Luciana Melo

Animação

Márlon Lima

Ilustração

Mario Vitor Gouveia Cau

Diagramação e Design Gráfico

Daniele Rossi

Design Web e Programação

Vando Pinto

Conteúdo

Anamaria Siriani de Oliveira
Antonio Seixlack
Arthur Fernandes da Silva
Bernardo Diniz Coutinho
Débora Silva Teixeira
Fabianna Resende de Jesus
Moraleida
Fernanda de Figueiredo Torres
Fernanda Martins Pereira
Hildebrandt
Fernanda Pereira de Paula Freitas
Francinete Araujo
Josimari Melo de Santana
Juliana Marques Coelho Bastos
Marco Túlio Cária Guimarães Pereira
Marcos Lisboa Neves
Marcos Paulo Veloso Correia
Mariana Cabral Schweitzer
Milene Zanoni da Silva
Rodrigo Macedo Pacheco
Rui Ferreira Afonso
Sandra Fortes

CRÉDITOS DESTE RECURSO DIDÁTICO

Conteúdo

Anamaria Siriani de Oliveira



UFPEL

